EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 69331
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-19 11:13:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EDUARDO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA			RUN	: 9.952.281-K
F.Nac	: 03-01-1964	Edad	: 59 AÑOS, 7 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: SANTA ELENA CAMINO JUNQUILLO PREV 26-01-2022			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 96397568		
Fecha Ingreso	: 15-08-2023	Fecha Egreso	: 2023-08-19 11:13:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.9-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-HIC talamocapsular derecha HIC-1. Día 19
-Hidrocefalia resuelta
-Traqueobronquitis 2° a K pneumoniae BLEE(+), tto completado 7/7, fin aislamiento 18/8/23
-Sd confusional hipoactivo
-Obs ACV isquémico con TH

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Historia clínica
Paciente con antecedentes de HTA, DM2 NIR, Hipotiroidismo y ACV (2022). Consulta el día 30/07/23 en HSC por caída en domicilio asociado a náuseas con vómitos, disartria y confusión, con paresia BCD°, se realiza TAC de cerebro que evidencia HIC tálamo capsular derecha 16 cc + hemoventrículo con dilatación ventricular inicial secundaria, evaluación en SU (afebril, ritmo sinusal, PAS 166) en estado de vigilia fluctuante entre sopor medio a superficial, GCS 10-12, disartria, hemiparesia severa izquierda. Evaluado por equipo de neurocirugía señalando no resolución quirúrgica, se traslada a UTI MQ, donde permanece con GCS 14-13 las primeras 48 horas de hospitalización. El 02/08/23 presenta deterioro de nivel de conciencia, con caída de GCS descrito hasta 8, control con TC de cerebro presenta mayor hidrocefalia, neurocirugía decide instalar DVE de urgencia. Postcirugía ingreso a UCI quirúrgica completando 5 días ATB con esquema ceftriaxona/metronidazol por sospecha de Neumonía aspirativa, CSB (-). El día 07/08/23 se retira DVE, permaneciendo estable los días siguientes, por lo que se traslada a UTAC el 08/08/23.
En UTAC el 09/08 presenta cuadro febril de hasta 38°C, inicia tratamiento antibiótico empírico esquema IAAS Vancomicina-Imipenem y reinicia BIC de urapidilo hasta estabilización. 10/08 se realiza ajuste tratamiento antihipertensivo por tendencia a hipotensión y se suspende BIC de urapidilo. 12/08 se recibe CSB que identifica Klebsiella BLEE, sensible a Imipenem. 14/08 evoluciona estable, afebril completando ATB con imipenem en Rehabilitación multidisciplinaria.
Paciente con buena evolución clínica, buen control cifras tensionales, sin episodio febril, en sala cohorte CD sin deposiciones lìquidas ni dolor, p inflamatorios bajos, hipernatremia resuelta.
En lo neurològico en vigilia espontànea, cooperador, desorientado, sin compromiso lenguaje, persiste con hemiplejia FBC izquierda con disartria leve, disfagia moderada a severa en plan de rehabilitacion. Hemisensitivo izquierdo. Sin deterioro clìnico, en condiciones de traslado a su centro de origen para Rehabilitaciòn.

Evolución
Paciente en REG, HDN con HTA leve, eupneico, afebril, hiperglicemia moderada, tolera bien

alimentación por SNG, no refiere molestias, cooperador, buen ánimo, sin tos ni disnea.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio mañana y control ambulatorio en policlínico de Neurología.

PLAN DE MANEJO:

-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control en policlínico Neurología
-Retiro de corchetes el 30/8/23

INDICACIONES AL ALTA

1. -Losartan 50 mg c/12
2. -Hidralazina 50 mg c/8h
3. -Amlodipino 10 mg/d
4. -Carvedilol (25 mg) 1-1/2
5. -Espironolactona 25 mg/d
6. -Atorvastatina (20 mg) 1/2 comp/noche
7. -Hidroclorotiazida 50 mg/d
8. -Levotiroxina 100 ug/d en ayuno
9. -Insulina NPH 10U AM

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e, hidratación N, yug no ing, rash(-), corchetes en cuero cabelludo con leve eritema, sin signos de infeccion (retiro 30/8/23)
-Cardiaco: RR, 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas, globo vesical(-)
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, desorientado en T-E, confuso, lenguaje fluente, nomina 2/4, repite frases largas, comprende órdenes de 3-4 pasos cruzando linea media con dificultad, resto n/e
-PC: CV impresiona hemianopsia izq por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izquierda leve, sensibilidad algésica facial impresiona N, disartria leve, nistagmo(-), úvula central, elevación palatina simétrica, lengua motilidad normal, fuerza ECM impresiona M5 bilateral, fuerza trapecio impresiona M0 izquierdo
-Motor: ESD M4-5, EID M2-3, BC izq M5, ESI M0, EII M1-2, RCP flexor izq y extensor derecho
-Sensitivo: impresiona hipoalgesia BC izquierda severa
-Cerebelo: n/e por confusión
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO